QFA (Questionário de Frequência Alimentar)
(Formulário em anexo)
O objetivo é estimar o consumo habitual de alimentos e nutrientes ao longo de um período
extenso (no seu caso, os últimos 12 meses).
A interpretação é feita através de:
Análise Qualitativa (Identificação de Padrões)
Esta é a forma mais direta e rápida de usar o questionário em um ambiente clínico para
aconselhamento. Você literalmente "lê" o questionário para identificar padrões de risco e de
proteção.
Como fazer: Você varre a tabela e observa a frequência marcada para grupos de alimentos
específicos:
● Padrão de Risco (Alto Consumo):
○ O paciente marcou "1 por dia" ou "2-3 por dia" em itens como: "Refrigerantes" , "Açúcar" , "Pão branco" , "Salgados" ou "Mortadela, chouriço, alheira"?

○ Interpretação: Isso indica um alto consumo habitual de açúcares adicionados, carboidratos refinados, sódio e gorduras saturadas/processadas.
● Padrão de Risco (Baixo Consumo):
○ O paciente marcou "<1 mês ou nunca" ou "1-3 por mês" em itens como: "Fruta fresca" , "Saladas e hortaliças" , ou "Leguminosas (feijão, grão)"?
○ Interpretação: Isso indica um baixo consumo habitual de fibras, vitaminas e minerais, que são protetores.
● Análise de Qualidade:
○ Qual gordura predomina? O consumo de "Azeite" é diário enquanto o de "Margarina" ou "Banha" é raro?
○ Qual proteína predomina? O consumo de "Peixes gordos" (ricos em ômega-3) é
a interpretação do QFA consiste em transformar as respostas de frequência em um perfil de
consumo habitual.
O objetivo, conforme declarado no seu documento, é entender o que o paciente costuma
comer ao longo de um período longo (ex: 12 meses).
A interpretação pode ser dividida em duas abordagens principais:
1. Análise Qualitativa (Padrões de Consumo)
Esta é a interpretação mais direta e rápida, ideal para o acompanhamento clínico. Você (o

profissional) "lê" o questionário preenchido para identificar padrões comportamentais, riscos
e pontos-chave para intervenção, analisando grupos de alimentos.
Ddetalhamento de como interpretar cada seção do seu QFA:
● I. Produtos Lácteos (Itens 1-8):
○ O que observar: A frequência de consumo é alta? Se sim, qual é a qualidade dessa fonte?
○ Interpretação: Um consumo diário de "Leite gordo" (item 1) e "Outros tipos de queijos" (item 8, que inclui queijos gordos) sugere uma alta ingestão de gordura saturada. Em contraste, um consumo diário de "Leite magro" (item 3) ou "Queijo magro, fresco" (item 6) sugere um perfil de menor risco.
● II. Carnes, Peixes e Ovos (Itens 9-23):
○ O que observar: Qual é a principal fonte de proteína do paciente?
○ Interpretação: Frequência alta (ex: 5-6 por semana ou diária) em "Carne de porco" (item 10), "Mortadela, chouriço..." (item 16) ou "Toucinho, bacon..." (item 17) é um grande sinal de alerta para alto consumo de gordura saturada, sódio e alimentos ultraprocessados. Em contrapartida, uma frequência maior em "Carne de frango, perú..." (item 11) ou "Peixes magros" (item 19) indica um padrão mais saudável.
● III. Óleos e Gorduras (Itens 24-29):
○ O que observar: Qual gordura é usada para cozinhar e temperar?
○ Interpretação: Consumo diário de "Azeite" (item 24) é um indicador positivo (gordura monoinsaturada). Consumo frequente de "Manteiga" (item 27) ou "Banha" (item 29) é um indicador de risco (gordura saturada).
● IV. Pão, Cereais e Derivados (Itens 30-37):
○ O que observar: Qualidade dos carboidratos.
○ Interpretação: Consumo diário elevado de "Pão branco..." (item 30) e "Flocos de
cereais açucarados" (item 34) indica uma dieta de alta carga glicêmica e baixa em fibras. O ideal seria ver uma frequência maior em "Pão integral..." (item 31) ou "Flocos... não açucarados" (item 33).
● V. Bolos, Bolachas, Sobremesas e Doces (Itens 38-45):
○ O que observar: Frequência do consumo de açúcar adicionado e ultraprocessados.
○ Interpretação: Frequência alta (diária ou várias vezes por semana) em "Outros tipos de bolachas" (item 39), "Croissant, bolos..." (item 40) ou "Açúcar" (item 45) é um alvo primário de intervenção para pacientes crônicos (diabetes, obesidade).
● VI. Hortaliças, Legumes e Frutas (Itens 46-56):
○ O que observar: Este é um dos grupos mais importantes. A frequência é baixa?
○ Interpretação: Se o paciente marcou "1-3 por mês" ou mesmo "1 por semana"

para "Fruta fresca" (item 52) ou "Saladas... e hortaliças" (item 47), isso é um grande déficit nutricional. Indica baixa ingestão de fibras, vitaminas e minerais, essenciais para o controle de doenças crônicas.

- VII. Bebidas (Itens 57-66) e VIII. Comida Rápida (Itens 67-71):
  - O que observar: Calorias líquidas, álcool e nível de processamento da dieta.
  - Interpretação: Consumo diário de "Refrigerantes" (item 61) ou "Sumos de fruta" (item 62) impacta diretamente o controle glicêmico. Frequência alta em "Salgados" (item 67), "Pizza" (item 68) ou "Hamburger" (item 69) indica uma dieta rica em sódio, gorduras de má qualidade e calorias.

Interpretação por Escore de Prontidão (Readiness Score)

Calcular um único escore que resume a "prontidão para a mudança" geral do indivíduo.

- Cálculo: (Contemplação + Ação + Manutenção) - Pré-Contemplação
  - Calcula-se a pontuação média de cada subescala e aplica-se a fórmula.
- Interpretação:
  - Escores Positivos Altos: Indicam alta motivação e prontidão para a mudança.
  - Escores Baixos ou Negativos: Indicam baixa prontidão. A Pré-Contemplação (resistência) é mais forte que as pontuações de prontidão (C, A, M).

Resumo da Aplicação Clínica

O objetivo principal da URICA é ajudar o profissional de saúde a adequar sua abordagem ao estágio do paciente. O resultado deve ser o perfil de maior pontuação + escore de prontidão à mudança/pré-contemplação

- Se o paciente está em Pré-Contemplação (PC alto): Não adianta propor um plano de ação. A intervenção deve focar em aumentar a conscientização sobre o problema (ex: entrevista motivacional).
- Se o paciente está em Ação (A alto): Ele está pronto para receber ajuda prática, como definir metas, discutir barreiras e receber apoio para o plano de mudança.

QFA (Questionário de Frequência Alimentar)

(Formulário em anexo)

O objetivo é estimar o consumo habitual de alimentos e nutrientes ao longo de um período extenso (no seu caso, os últimos 12 meses).

A interpretação é feita através de:

Análise Qualitativa (Identificação de Padrões)

Esta é a forma mais direta e rápida de usar o questionário em um ambiente clínico para aconselhamento. Você literalmente "lê" o questionário para identificar padrões de risco e de proteção.

Como fazer: Você varre a tabela e observa a frequência marcada para grupos de alimentos específicos:

- Padrão de Risco (Alto Consumo):
  - O paciente marcou "1 por dia" ou "2-3 por dia" em itens como: "Refrigerantes" , "Açúcar" , "Pão branco" , "Salgados" ou "Mortadela, chouriço, alheira"?
  - Interpretação: Isso indica um alto consumo habitual de açúcares adicionados, carboidratos refinados, sódio e gorduras saturadas/processadas.
- Padrão de Risco (Baixo Consumo):
  - O paciente marcou "<1 mês ou nunca" ou "1-3 por mês" em itens como: "Fruta fresca" , "Saladas e hortaliças" , ou "Leguminosas (feijão, grão)"?

○ Interpretação: Isso indica um baixo consumo habitual de fibras, vitaminas e minerais, que são protetores.
● Análise de Qualidade:
○ Qual gordura predomina? O consumo de "Azeite" é diário enquanto o de "Margarina" ou "Banha" é raro?
○ Qual proteína predomina? O consumo de "Peixes gordos" (ricos em ômega-3) é
a interpretação do QFA consiste em transformar as respostas de frequência em um perfil de consumo habitual.
O objetivo, conforme declarado no seu documento, é entender o que o paciente costuma comer ao longo de um período longo (ex: 12 meses).
A interpretação pode ser dividida em duas abordagens principais:
1. Análise Qualitativa (Padrões de Consumo)
Esta é a interpretação mais direta e rápida, ideal para o acompanhamento clínico. Você (o profissional) "lê" o questionário preenchido para identificar padrões comportamentais, riscos e pontos-chave para intervenção, analisando grupos de alimentos.
Detalhamento de como interpretar cada seção do seu QFA:
● I. Produtos Lácteos (Itens 1-8):
○ O que observar: A frequência de consumo é alta? Se sim, qual é a qualidade dessa fonte?
○ Interpretação: Um consumo diário de "Leite gordo" (item 1) e "Outros tipos de queijos" (item 8, que inclui queijos gordos) sugere uma alta ingestão de gordura saturada. Em contraste, um consumo diário de "Leite magro" (item 3) ou "Queijo magro, fresco" (item 6) sugere um perfil de menor risco.
● II. Carnes, Peixes e Ovos (Itens 9-23):
○ O que observar: Qual é a principal fonte de proteína do paciente?
○ Interpretação: Frequência alta (ex: 5-6 por semana ou diária) em "Carne de porco" (item 10), "Mortadela, chouriço..." (item 16) ou "Toucinho, bacon..." (item 17) é um grande sinal de alerta para alto consumo de gordura saturada, sódio e alimentos ultraprocessados. Em contrapartida, uma frequência maior em "Carne de frango, perú..." (item 11) ou "Peixes magros" (item 19) indica um padrão mais saudável.
● III. Óleos e Gorduras (Itens 24-29):
○ O que observar: Qual gordura é usada para cozinhar e temperar?
○ Interpretação: Consumo diário de "Azeite" (item 24) é um indicador positivo (gordura monoinsaturada). Consumo frequente de "Manteiga" (item 27) ou "Banha" (item 29) é um indicador de risco (gordura saturada).
● IV. Pão, Cereais e Derivados (Itens 30-37):
○ O que observar: Qualidade dos carboidratos.
○ Interpretação: Consumo diário elevado de "Pão branco..." (item 30) e "Flocos de cereais açucarados" (item 34) indica uma dieta de alta carga glicêmica e baixa em fibras. O ideal seria ver uma frequência maior em "Pão integral..." (item 31) ou "Flocos... não açucarados" (item 33).
● V. Bolos, Bolachas, Sobremesas e Doces (Itens 38-45):
○ O que observar: Frequência do consumo de açúcar adicionado e ultraprocessados.
○ Interpretação: Frequência alta (diária ou várias vezes por semana) em "Outros tipos de bolachas" (item 39), "Croissant, bolos..." (item 40) ou "Açúcar" (item 45) é um alvo primário de intervenção para pacientes crônicos (diabetes,

obesidade).
● VI. Hortaliças, Legumes e Frutas (Itens 46-56):
○ O que observar: Este é um dos grupos mais importantes. A frequência é baixa?
○ Interpretação: Se o paciente marcou "1-3 por mês" ou mesmo "1 por semana" para "Fruta fresca" (item 52) ou "Saladas... e hortaliças" (item 47), isso é um grande déficit nutricional. Indica baixa ingestão de fibras, vitaminas e minerais, essenciais para o controle de doenças crônicas.
● VII. Bebidas (Itens 57-66) e VIII. Comida Rápida (Itens 67-71):
○ O que observar: Calorias líquidas, álcool e nível de processamento da dieta.
○ Interpretação: Consumo diário de "Refrigerantes" (item 61) ou "Sumos de fruta" (item 62) impacta diretamente o controle glicêmico. Frequência alta em "Salgados" (item 67), "Pizza" (item 68) ou "Hamburger" (item 69) indica uma dieta rica em sódio, gorduras de má qualidade e calorias.

Questionários de Rastreio Oncológico (Adesão)

Este não é um questionário de pontuação, mas sim um checklist de comportamento preventivo.

1. **(Para mulheres ≥ 25 anos) Quando foi seu último exame Papanicolau?**
    - (Opções: Nunca fiz; Há mais de 3 anos; Nos últimos 3 anos)
2. **(Para mulheres ≥ 40-50 anos, conforme protocolo) Quando foi sua última mamografia?**
    - (Opções: Nunca fiz; Há mais de 2 anos; Nos últimos 2 anos)
3. **(Para todos ≥ 45-50 anos) Você já fez algum exame para rastreio de câncer de intestino (sangue oculto nas fezes ou colonoscopia)?**
    - (Opções: Nunca fiz; Sim, há mais de 1 ano; Sim, no último ano)
4. **(Para homens ≥ 50 anos) Você já discutiu com seu médico sobre o rastreamento do câncer de próstata (PSA)?**
    - (Opções: Não; Sim, mas não realizei exames; Sim, e realizo acompanhamento)

Interpretação

- **Cálculo:** Não se calcula uma pontuação. A avaliação é qualitativa.
- **Resultado e Acompanhamento:** O objetivo é monitorar a adesão ao longo do tempo, transformando as respostas "Nunca fiz" ou "Há mais de X anos" em respostas que indiquem que o rastreio está em dia, conforme as diretrizes clínicas. O sucesso é medido pela realização dos exames.

A Escala Transversal de Sintomas de Nível 1 (Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure)

1. Sistema de Pontuação (Likert)

Cada item é avaliado em uma escala de 5 pontos baseada na frequência/gravidade nas últimas duas semanas:

0 = Nenhuma (None)
1 = Leve / Rara (Slight)

2 = Moderada / Vários dias (Mild)
3 = Grave / Mais da metade dos dias (Moderate)
4 = Muito Grave / Quase todos os dias (Severe)

2. Gabarito por Domínio e Ponto de Corte

A regra geral para investigação adicional é uma pontuação **≥ 2 (Moderada)**. No entanto, para domínios de risco (Suicídio, Psicose, Substâncias), o corte é mais baixo (**≥ 1**).

Domínio	Questões (Itens)	Ponto de Corte (Gatilho)	Ação Recomendada se Positivo
I. Depressão	1, 2	≥ 2 (Moderada)	Avaliar risco; Aplicar PROMIS Nível 2 - Depressão.
II. Raiva / Irritabilidade	3, 4, 5	≥ 2 (Moderada)	Aplicar PROMIS Nível 2 - Raiva.
III. Mania	6, 7	≥ 2 (Moderada)	Aplicar Escala Nível 2 - Mania (Altman).
IV. Ansiedade	8, 9, 10	≥ 2 (Moderada)	Aplicar PROMIS Nível 2 - Ansiedade.
V. Sintomas Somáticos	11, 12	≥ 2 (Moderada)	Avaliar etiologia médica; Aplicar Nível 2 - Somáticos (PHQ-15).
VI. Ideação Suicida	13	≥ 1 (Leve)	ATENÇÃO IMEDIATA. Avaliação de segurança e risco de suicídio.
VII. Psicose	14, 15	≥ 1 (Leve)	Avaliação clínica detalhada para transtornos psicóticos.
VIII. Alterações do Sono	16	≥ 2 (Moderada)	Aplicar PROMIS Nível 2 - Perturbação do Sono.
IX. Memória	17	≥ 2 (Moderada)	Avaliação neuropsicológica ou testes breves de rastreio cognitivo.
X. Pensamentos Repetitivos	18, 19	≥ 2 (Moderada)	Aplicar Nível 2 - Pensamentos e Comportamentos Repetitivos.
XI. Dissociação	20	≥ 2 (Moderada)	Investigação clínica para transtornos dissociativos.
XII. Funcionamento da Personalidade	21, 22	≥ 2 (Moderada)	Avaliação mais aprofundada da personalidade.
XIII. Uso de Substâncias	23	≥ 1 (Leve)	Aplicar Nível 2 - Uso de Substâncias (ASSIST ou similar).

3. Como Proceder (Fluxograma Rápido)

1. **Aplicação:** O paciente preenche as 23 perguntas.
2. **Revisão:** O clínico verifica as respostas.
3. **Triagem:**
○
Se todas as respostas forem **0 ou 1** (exceto nos domínios de risco): O paciente está "negativo" para sintomas significativos naquele domínio. Acompanhamento de rotina.○
Se houver respostas **≥ 2** (ou **≥ 1** para Suicídio/Psicose/Substâncias): O domínio é considerado **positivo**.
4. **Ação:** Para cada domínio positivo, deve-se realizar uma entrevista clínica focada naquele sintoma para confirmar o diagnóstico ou aplicar a **Escala de Nível 2** correspondente (ferramentas mais detalhadas do DSM-5).

Observação Importante

O item 13 (**Ideação Suicida**) é crítico. Qualquer pontuação acima de 0 exige que o clínico pare a avaliação padrão e conduza uma avaliação de risco de suicídio imediata para garantir a segurança do paciente.

A PREVENT™ (PREDICTing Risk of Cardiovascular Disease EVENTs)

Gabarito:

Risco Estimado (10 anos)	Classificação	Conduta Geral Sugerida (Diretrizes AHA/ACC)
< 5%	Baixo Risco	Enfatizar estilo de vida saudável. Reavaliar periodicamente.
5% a < 7,5%	Risco Limítrofe (Borderline)	Discutir riscos/benefícios. Considerar estatinas se houver fatores agravantes (enhancers).
7,5% a < 20%	Risco Intermediário	Iniciar discussão sobre terapia com estatina de moderada intensidade + mudanças no estilo de vida.
≥ 20%	Alto Risco	Terapia intensiva com estatinas e controle rigoroso de fatores de risco é fortemente recomendada.

https://github.com/martingmayer/preventr.git

SHORT MULTIDIMENSIONAL INVENTORY LIFESTYLE EVALUATION (SMILE)

Gabarito:

Visualização Recomendada

Para o paciente visualizar o resultado, o padrão ouro para esta escala multidimensional é o **Gráfico de Radar (Teia de Aranha)**, onde cada ponta é um domínio.

1. Sistema de Pontuação (Input)

Cada resposta do usuário deve receber um valor numérico (Escala Likert de 4 pontos):
Nunca = 1 ponto
Raramente = 2 pontos
Frequentemente = 3 pontos
Sempre = 4 pontos

2. Regra de Inversão

Alguns domínios possuem perguntas com conotação negativa. O algoritmo deve inverter a nota antes de calcular a média.
(Fórmula de inversão: 5 - Resposta do Usuário).
●
●
Domínios Positivos (Mantém a nota original: 4 é bom):

1. Dieta e Nutrição
2. Atividade Física
3. Sono Restaurador
4. Suporte Social
5. Comportamento Preventivo (Segurança)
6. Manejo do Estresse (Perguntas sobre relaxamento)

Domínios/Itens Negativos (Inverter a nota: 4 é ruim, vira 1):

1. **Uso de Substâncias** (Álcool, Tabaco, Drogas).
2. **Estresse** (Se a pergunta for "Sinto-me sobrecarregado"
, deve ser invertida).

3. Cálculo do Escore

Não existe um "Total Geral"
. O gabarito é calculado pela **Média Aritmética por Domínio**.
$$\text{Escore do Domínio} = \frac{\sum \text{Pontos (já invertidos se necessário)}}{\text{Número de Questões do Domínio}}$$

4. Interpretação Final (Output para o Usuário)

Use este "farol" para dar o feedback visual no App:

Escore Médio	Classificação	Feedback
1,00 a 1,99	🔴 Risco (Baixo)	Estilo de vida não saudável. Requer intervenção imediata.
2,00 a 2,99	🟡 Alerta (Médio)	Comportamentos inconsistentes. Necessita melhoria.
3,00 a 4,00	🟢 Proteção (Alto)	Estilo de vida saudável/protetor. Manutenção.

Escala Comportamento Sedentário

Gabarito:

Faixa Selecionada	Estimativa de Horas	Classificação de Risco
Menos de 3h/dia	Baixo Risco	Ideal.
De 3h a 6h/dia	Risco Moderado	Comum, requer atenção a pausas ativas.
Das 6h às 8h/dia	Risco Elevado	"Zona de perigo" . A partir de 6-8h, o risco de mortalidade por todas as causas aumenta.
Das 8h às 12h/dia	Risco Muito Alto	Necessita intervenção comportamental urgente.
Mais de 12 horas/dia	Risco Crítico	Altíssima probabilidade de síndrome metabólica associada.

Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI)

Gabarito:

Instruções de Pontuação (Gabarito Técnico)

O escore final (Global) varia de **0 a 21**.

-

Pontuação Global > 5 indica má qualidade do sono.

Componente 1: Qualidade Subjetiva do Sono

-

Baseado na Pergunta 6 (Como avaliaria a qualidade do seu sono...)
●
Pontuação:
○
Muito boa = **0**
○
Boa = **1**
○
Ruim = **2**
○
Muito ruim = **3**
Componente 2: Latência do Sono (Demora para adormecer)
Este cálculo envolve dois passos:
1. **Pontue a Pergunta 2** (Tempo em minutos para adormecer):
○
≤ 15 minutos = 0
○
16–30 minutos = 1
○
31–60 minutos = 2
○
60 minutos = 32. **Pontue a Pergunta 5a** (Frequência que não conseguiu adormecer em 30 min):
○
Nenhuma vez = 0
○
< 1 vez/semana = 1
○
1–2 vezes/semana = 2
○
≥ 3 vezes/semana = 3
3. **Cálculo Final do Componente 2:**
○
Some os pontos do passo 1 e 2.
○
Atribua a nota final:
■ Soma 0 = **0**
■ Soma 1 ou 2 = **1**
■ Soma 3 ou 4 = **2**
■ Soma 5 ou 6 = **3**
Componente 3: Duração do Sono
●
Baseado na Pergunta 4 (Quantas horas de sono *real*):
●
Pontuação:
○
7 horas = **0**
○
6 a 7 horas = **1**
○
5 a 6 horas = **2**
○
< 5 horas = **3**
Componente 4: Eficiência Habitual do Sono
Requer cálculo matemático:
1. Calcule as **Horas no Leito**: (Hora de levantar da Perg. 3) – (Hora de deitar da Perg. 1).
2. Calcule a **Eficiência**: (Horas dormidas da Perg. 4 ÷ Horas no Leito) × 100.

3. **Pontuação Final:**
○
85% = **0**
○
75 – 84% = **1**
○
65 – 74% = **2**
○
< 65% = **3**
Componente 5: Distúrbios do Sono
1. Some as pontuações brutas (0 a 3) das perguntas **5b até 5j**.
2. **Pontuação Final do Componente 5** (Baseada na soma):
○
Soma 0 = **0**
○
Soma 1 a 9 = **1**
○
Soma 10 a 18 = **2**
○
Soma 19 a 27 = **3**
Componente 6: Uso de Medicamentos para Dormir
●
Baseado na Pergunta 7 (Frequência de uso de remédio):●
Pontuação:
○
Nenhuma vez = **0**
○
< 1 vez/semana = **1**
○
1–2 vezes/semana = **2**
○
≥ 3 vezes/semana = **3**
Componente 7: Disfunção Durante o Dia
Envolve dois passos:
1. **Pontue a Pergunta 8** (Dificuldade em ficar acordado):
○
Nenhuma vez = 0
○
< 1 vez/semana = 1
○
1–2 vezes/semana = 2
○
≥ 3 vezes/semana = 3
2. **Pontue a Pergunta 9** (Entusiasmo para atividades):
○
Nenhum problema = 0
○
Problema leve = 1
○
Problema razoável = 2
○
Grande problema = 3
3. **Cálculo Final do Componente 7:**
○
Some os pontos do passo 1 e 2.
○
Atribua a nota final:
■ Soma 0 = **0**

■ Soma 1 ou 2 = **1**
■ Soma 3 ou 4 = **2**
■ Soma 5 ou 6 = **3**

Resultado Final (Cálculo Global)

Some os escores dos **Componentes 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7**.

Pontuação Total	Classificação
0 – 4 pontos	Boa Qualidade do Sono
5 – 10 pontos	Qualidade Ruim (Exige atenção)

> 10 pontos Distúrbio do Sono (Indica encaminhamento médico)

Para a triagem digital, o Componente 4 é o um pouco chato de programar porque lida com horário (formato hora/minuto). Se quiser simplificar, pode perguntar diretamente **"Quantas horas você passa na cama?"** em vez de calcular a diferença entre deitar/levantar.